

Fecha Última Actualización: 16-08-2024 12:29:52

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Luis Orlando Díaz Piñeda

Edad : 39a 1m 9d

Dirección : Pasaje Constanza 1958 Magdalena Un

Rut : 16.044.081-3

Fecha Nacto: 07/07/1985

Comuna : La Pintana

N° Archivo : 1624004

Sexo : Masculino

Teléfono : 955315486

N° Epicrisis

410198

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Ingreso : 15/08/2024 08:00

Días Estadía : 1

Unidad de Egreso : Medicina Agudos 2° Piso

Fecha Egreso : 16/08/2024 10:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

ingreso electivo administración de inmunoglobulinas

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

- Médicos: Agenesia renal, doble trasplantado DC (2009/abril 2022; Inducción con Timoglobulina - IS Tacrolimus + Micofenolato), Insuficiencia renal por RVU, HTA. Agotamiento de accesos vasculares. Usuario de ileostomía terminal post perforación accidental de colon (en cirugía de trasplante), en plan de reconstitución. Malformación anorrectal con múltiples cirugías, Hiperparatiroidismo operado 2020.

- Quirúrgicos: Trasplante renal (2009 y abril/2022), 4 FAV trombosadas, apendicectomía (2019), paratiroidectomía (2020), hemicolectomía derecha + Ileostomía terminal y rafia (mayo/2022), nefrostomía (junio /2022), Fistula vésico- cutánea resuelta - Nefrostomía + doble JJ 30/06- retirado Sept 2022

- Medicamentos: Micofenolato 540 mg cada 12 hrs, prednisona 5 mg cada 24 horas, tacrolimus 1 mg cada 12 horas, cotrimoxazol forte diaria, omeprazol 20 mg al día, bicarbonato 2 g c/12 hrs, atorvastatina 20 mg, carbonato de calcio 500 mg.

- Alergias: Látex (PCR recuperado)

- Hábitos: Tabaco (-) OH (-) Drugs (-)

- Hospitalizaciones:

Dic 2022 por pielonefritis y disfunción de injerto con creat 4 mg/dl, al alta con su creatinina basal 1 mg/dl.

Enero 2023 por nueva pielonefritis, completa tto en UHD el 07/02.

- Inmunizaciones: Covid 4 dosis, influenza 2022 (+) - 2023 (-), neumococo 2022

ANAMNESIS

Paciente de 39 años, en seguimiento por nefrología, presentado en comité de trasplante el 18/07 en relación a deterioro progresivo de función renal, elevada carga de anticuerpos e imposibilidad de realizar biopsia renal. Se determina tratamiento de PSAE con ceftazidima por 5 días, luego infusión de inmunoglobulina y posterior evaluación para inicio de rituximab. Ingresa electivamente para infusión de inmunoglobulinas; a su ingreso a Unidad en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, examen físico sin hallazgos relevantes.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- Disfunción de injerto renal

Infusión de inmunoglobulinas

- Antecedentes (Trasplantado renal)

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

Fecha Epicrisis : 16/08/2024 12:29

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 16-08-2024 12:29:52

Página 2 de 3

Nefrología: Disfunción trasplante renal. Crea actual 1.83. Evaluado en Comité 18/07 indica inmunoglobulinas 2 g/Kg (100 g) y posterior reevaluación para inicio de rituximab. Se administran 100 g totales en infusión progresiva bien tolerada 15/08 sin incidentes. Evaluado por especialidad, se decide egreso hospitalaria con control ambulatorio en policlínico de trasplante renal.

EXÁMENES

01/08: Crea 1.83, Hto 47.9, Leucocit 7580, RAL 1910, Plq 268.000 142/3.28 Ca 8.5, Glic 75, Alb 4.0, Col 142, ProtU 0.46, UC Pseudomonas aeruginosas S AMK, Cefta, tazonom Tacro 8.7 IgA 236, IgG 1162, IgM 69

BIOPSIA DE INJERTO RENAL: Septiembre de 2023

Corresponde a Categoría 3 de Categorías Diagnósticas de Banff: sospechoso (borderline) para rechazo agudo mediado por células

- Compromiso túbulo-intersticial discreto (atrofia tubular y fibrosis intersticial 10%)
- C4d negativo y SV40-T negativo para virus Polioma
- Arterioesclerosis y arterioloesclerosis discretas.

CONDICIÓN ACTUAL

Paciente en buenas condiciones generales, con buena evolución clínica, hemodinámicamente estable y afebril, sin apremio ventilatorio ni requerimientos de O2 suplementario. Niega dolor u otras molestias. Dada buena evolución, se decide alta domiciliaria.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

- Disfunción de injerto renal
- Infusión de inmunoglobulinas 15/08
- Antecedentes (Trasplantado renal)

Diagnóstico de Egreso

Organos Y Tejidos Trasplantados -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en buenas condiciones generales, con buena evolución clínica, hemodinámicamente estable y afebril, sin apremio ventilatorio ni requerimientos de O2 suplementario. Niega dolor u otras molestias. Dada buena evolución, se decide alta domiciliaria.

Plan Post Alta

INDICACIONES

REPOSO: Relativo.

RÉGIMEN: bajo en sodio, potasio y fósforo.

MEDICAMENTOS:

Micofenolato 540 mg cada 12 hrs VO

Prednisona 5 mg cada 24 horas VO

Tacrolimus 1 mg cada 12 horas VO

Cotrimoxazol forte 1 comprimido diario VO

Omeprazol 20 mg al día 1 comprimido al día VO

Bicarbonato 2 g c/12 hrs VO

Atorvastatina 20 mg, 1 comprimido al día VO

Carbonato de calcio 500 mg al día VO

CONTROLES:

Continuar controles con Nefrología para seguimiento y eventual inicio de Rituximab. Mantener disponible teléfono celular para ser contactado desde ambulatorio.

ACUDIR A SERVICIO DE URGENCIAS: en caso de dolor o fiebre sobre 38°C que no cede al uso de paracetamol, dolor opresivo en el pecho de más de 30 minutos, sensación de falta de aire, uso de costillas o abdomen para respirar, compromiso de conciencia, o en caso que el paciente estime pertinente.

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 16/08/2024 12:29

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 16-08-2024 12:29:52

Página 3 de 3

Tipo de Reposo : Bajo En Sodio, Potasio Y Fósforo.

Régimen Alimentario : Relativo

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Sofia Soto Perez

Becado/Residente

Tomás Lahera Frohmann

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/08/2024 12:29

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:11

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar